

# VANCOMICINA ENDOVENOSA

## 1. ESTABELECE A DOSE E QUANDO COLHER A PRIMEIRA VANCOCINEMIA

DOSE DE ATAQUE: 30 mg/kg de peso atual – dose máxima de ataque 2250mg

| CLCr (ml/min)                  | DOSE                                                  | 1ª VANCOCINEMIA                | REPETIR VANCOCINEMIA   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| >90                            |                                                       |                                |                        |
| idade ≤ 35 anos                | 15 mg/kg/dose (3x/dia)                                | 30 minutos antes da 4ª dose    | idem                   |
| idade > 35 anos                | 15 mg/kg/dose (2x/dia)                                |                                |                        |
| 50-90                          | 15 mg/kg/dose (2x/dia)                                | 30 minutos antes da 4ª dose    | idem                   |
| 30-49                          | 15 mg/kg/dose (1x/dia)                                | 30 minutos antes da 3ª dose    | idem                   |
| <30                            | 15 mg/kg dose única                                   | Dosagem aleatória após 24h     | idem                   |
| IHD – hemodiálise intermitente | 10 mg/kg até dose máxima de 1500mg após sessão de IHD | Imediatamente antes da 3ª dose | Antes da sessão de IHD |

- Dose máxima: 2250 mg 2x/dia OU 1500 mg 3x/dia.

## 2. CORREÇÃO DA DOSE APÓS VANCOCINEMIA

### A. PACIENTE COM CLCr ≥ 30 ml/min E DOSE INDIVIDUAL ≤ 1500 mg

| VANCOCINEMIA (MCG/ML) | DOSE q8h                            | DOSE q12h                           | DOSE q24h                           |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ≤ 5                   | Trocar ATB                          | Alterar q8h, mesma dose em mg       | Alterar q12h, mesma dose em mg      |
| 5,1-10                | ↑ 500mg<br>manter q8h               | ↑ 500mg<br>manter q12h              | ↑ 500mg<br>manter q124h             |
| 10,1-15               | ↑ 250mg<br>manter q8h               | ↑ 250mg<br>manter q12h              | ↑ 250mg<br>manter q24h              |
| 15,1-20               | Manter dose atual                   | Manter dose atual                   | Manter dose atual                   |
| 20,1-25               | ↓ 250 mg<br>manter q8h              | ↓ 250 mg<br>manter q12h             | ↓ 250 mg<br>manter q24h             |
| > 25                  | Suspender até atingir < 20 mcg/ml * | Suspender até atingir < 20 mcg/ml * | Suspender até atingir < 20 mcg/ml * |

- \* Monitorar vancocinemia a cada 24h até atingir < 20 mcg/ml, quando atingir < 20 mcg/ml repetir uma dose de 15 mg/kg e checar a vancocinemia após 24h.

- \* Níveis elevados podem estar associados à lesão renal induzida pela vancomicina, considerar terapia alternativa se ocorrer nefrotoxicidade.

### B. PACIENTE COM CLCr <30 ml/min: Nova dose de 15mg/kg se a vancocinemia < 20mcg/ml.

### C. PACIENTE EM IHD: sessão de 3 horas, com alto fluxo, redução esperada de 40% nos níveis séricos

| VANCOCINEMIA PRÉ-DIÁLISE (mcg/mL) | AJUSTE DE DOSE                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤ 20                              | ↑ 250 mg, após sessão de IHD                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20,1-30                           | Manter dose atual, após sessão de IHD                                                                                                                                                                                                                                          |
| > 30                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspender</li> <li>• Monitorar vancocinemia a cada 24h até atingir &lt; 25 mcg/ml</li> <li>• Administrar dose corrigida ↓ 250 a ↓ 500 mg após diálise</li> <li>• Repetir vancocinemia imediatamente antes da sessão de IHD</li> </ul> |

## 3. DURAÇÃO DA INFUSÃO

| DOSE        | DURAÇÃO DA INFUSÃO |
|-------------|--------------------|
| ≤ 500       | 30 min             |
| 750 -1250   | 60 min             |
| 1500 -1750  | 90 min             |
| 2000 - 2250 | 120 min            |